

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	頭部外傷 Head Injury				
編號	A31000-Q03-W-A04	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 09 月 06 日
版本/總頁數	第 3.5 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解頭部外傷的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

頭部外傷顧名思義是頭部受到外力直接或間接作用所造成的一種傷害；嚴重的頭部外傷，會導致病人的意識障礙。

（二）症狀

意識程度改變、混亂、瞳孔大小與對光反應不正常、突然發生之神經功能障礙、生命徵象改變、視力缺損、聽力損傷、感覺功能障礙、肌肉強直、頭痛、眩暈、抽搐發作等。若病人出現低血容積性休克之症狀時，如血壓下降、呼吸與脈搏變快，則可能為多個系統受創。

（三）常見檢查

- 1.X 光檢查－頭部、頸椎、胸部(X-ray)。
- 2.電腦斷層攝影(Computerized Tomography；CT)。
- 3.核磁共振檢查(Magnetic Resonance Image)。
- 4.完全的血球計數(CBC／DC)。
- 5.體液電解質(Electrolyte)。

主題名稱	頭部外傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/9

6.動脈血氧分析(Blood Gas)。

(四) 常見治療

首要治療目標為降低因創傷所導致的顱內壓上升。創傷後會引發抽搐發作，因此在其未發作之前可給予抗痙攣劑預防；另外不論是開放性或閉鎖性頭部外傷均可能會出現感染現象，因此抗生素的投予亦是必要的治療方式。

(五) 護理問題

1. 顱內壓力調適困難／腦，與顱內壓上升、自動調節機轉失效、缺氧有關。
2. 身體活動能力異常／疲倦、偏癱、肌肉強直有關。
3. 易受傷害／抽搐發作、躁動不安、混亂有關。
4. 易肺吸入／意識程度改變有關。
5. 呼吸道清除功能不良／呼吸型態改變、分泌物積存有關。
6. 缺乏營養／吞嚥能力失調、代謝狀況改變、限制水分攝入、意識不清有關。

(六) 護理措施

1. 顱內壓力調適困難／腦，與顱內壓上升、自動調節機轉失效、缺氧有關。
 - (1)神經功能、瞳孔反應、生命徵象的評估並記錄之。
 - (2)觀察並記錄意識狀態的變化。
 - (3)監測病人有無顱內壓增高症狀出現，並衛教顱內壓升高的危險性及徵象。
 - (4)提供少刺激的環境，注意病人之安全性，教導使用床欄，必要時予保護性約束，並向家屬解釋。
 - (5)預防體溫過高，可使大腦的新陳代謝率上升，因而增加顱內壓及大腦血容積。
 - (6)評估病人有無頭痛增加的情形，特別是在清晨及有無伴隨噁心、嘔吐的症狀。
 - (7)維持呼吸道通暢，必要時給予抽痰；限制抽吸時間於 10-15 秒內；抽吸前後予以過度換氣。
 - (8)評估呼吸深度及型態，監測動脈血氣體分析值。

主題名稱	頭部外傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/9

(9)依醫囑給予氧氣使用並監測血氧濃度以維持氧合。

(10)依醫囑給予（滲透性利尿劑、類固醇等），並注意病人反應。

(11)觀察有無癲癇發作的情形，並依醫囑給予（抗癲癇、抽搐之藥物），並記錄其型態、時間等。

(12)教導維持身體姿勢成一直線避免臀部過度屈曲俯臥及特倫博士臥位。

(13)且抬高床頭<30 度，以促進腦部靜脈回流及呼吸功能。

(14)教導避免胸內壓與腹內壓的方法；如用力咳嗽、用力解便、彎腰等。

(15)教導病人避免 Valsalvs's maneuver 及等長運動。

(16)建議採漸進式活動並避免過多的活動或突發動作。

(17)監測顱內壓是否在護理活動及治療後有上升的情形，並視需要調整照護，儘量採集中護理。

2. 身體活動能力異常／疲倦、偏癱、肌肉強直有關

(1) 建議漸進式活動並教導並示範移動技巧。

(2) 協助並教導病人從主動全關節運動漸進至功能性活動。

(3) 示範增加活動力的方法及 ROM 等長運動、等張運動。

(4) 教導活動時注意之安全措施。

(5) 協助並教導正確使用輔助器。

(6) 教導病人患肢執行被動關節運動。

(7) 教導病人健肢執行主動關節運動。

(8) 依醫囑予骨骼肌鬆弛劑。

(9) 評值病人身體活動功能活動後反應。

3. 易受傷害／抽搐發作、躁動不安、混亂有關

(1) 向病人及其家屬說明抽搐的原因。

(2) 發作時需維持呼吸道的通暢，頭側一邊或側臥的姿勢以防異物吸入或舌

頭往後垂而阻礙呼吸；可給予 Bite 或乾淨的布放在病人上下齒間，勿強行扳開。

主題名稱	頭部外傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/9

(3) 若口鼻分泌物過多，給予抽吸，並給予氧氣使用。

(4) 依醫囑給與鎮靜劑。

(5) 觀察抽搐發生的時間、型態、部位並記錄之。

(6) 減少跌倒的發生機會，應使用床欄。

(7) 病人佩帶識別手圈。

(8) 漸進式活動，並建議至少一個家屬隨時陪伴。

(9) 將病人安排在靠近護理站的病房。

4. 易肺吸入／與意識程度改變有關

(1) 注意評估病人意識狀態，嗜睡或混亂時勿給予進食。

(2) 注意病人有痰時，協助咳出或需要時執行抽痰，以維持呼吸道通暢。

(3) 維持口腔衛生，若需要時清除口腔和喉頭分泌物。

(4) 口腔分泌物、痰多時儘量採側睡，並常予探視。

(5) 進食時病人應採取坐姿。

(6) 食物應易於咀嚼和吞嚥，例如：軟質食物或細緻食物。

(7) 應讓病人有充分時間進食。

(8) 病人進食時應有人在旁陪伴，且應親自或教導家屬注意肺吸入症狀。

(9) 進食完畢，應檢查病人口腔，確定無食物殘存口中。

(10) 抽吸用物應準備在床旁。

(11) 必要時依醫囑改由鼻胃管餵食。

5. 呼吸道清除功能不良／呼吸型態改變、分泌物積存有關

(1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。

(2) 監測脈搏血氧濃度和動脈血液氣體分析值。

(3) 協助病人採高坐臥姿；至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。

(4) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。

(5) 必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間以 10 秒為限。

(6) 抽吸前後，先給予氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。

主題名稱	頭部外傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/9

- (7) 依醫囑執行胸部物理治療，例如姿位引流。
 - (8) 提供病人足夠氧合狀態：鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
 - (9) 依醫囑給予濕潤的氧氣，尤其當病人身上有人工氣管時。
 - (10) 依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。
6. 缺乏營養／少於身體需要，與吞嚥能力失調、代謝狀況改變、限制水分攝入、意識不清有關

- (1) 測量體重。
- (2) 依醫囑監測血液白蛋白檢驗值變化。
- (3) 計算病人每日所需攝取熱量及實際食物攝取熱量。
- (4) 評估有無消化不良、腹脹、腹瀉情況。
- (5) 配合病人食物喜好選擇高蛋白質、高熱量食物。
- (6) 採坐姿或半坐姿進食並給予充分時間進食、勿催促，必要時協助進食。
- (7) 與營養師共同建立飲食計畫，視病人情況及需求適時修訂。
- (8) 依醫囑每日供給液體輸注。
- (9) 建議少量多餐以增加進食量。
- (10) 衛教營養狀況少於身體需要的症狀，徵象及避免的重要性。

(七) 衛教指導

- 1. 教導病人於床上移位、排便時避免採用 Valsalva's 動作，即閉氣用力運動，在床上翻身或移位時，最好於吐氣時開始動作。
- 2. 鼓勵攝取高纖維飲食，避免便秘情形。
- 3. 告知家屬及病人顱內壓升高之症狀：躁動不安、頭痛、呼吸費力、無目的的活動、意識模糊、頭痛、嘔吐。
- 4. 教導抬高床頭 30 度，避免採取頭低腳高及俯臥姿勢，造成顱內壓升高。
- 5. 保護病人並注意床欄使用，預防跌倒發生。
- 6. 預下床活動時需先半坐臥 5-10 分鐘，若無頭暈情形再緩慢起身活動，勿快速改變姿勢造成姿勢性低血壓發生。

主題名稱	頭部外傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/9

- 7.若病人發燒，教導正確冰枕使用方式，頭部有傷口者以腋下夾冰方式使用，並注意冰枕每使用 30 分鐘需暫時休息；另外可穿著棉質易吸汗衣物，及調整室內溫度；若病人有寒顫發冷情形，可先增加被蓋保暖。
- 8.保持環境的安靜，減少不必要之刺激，以提供病人充分的休息。
- 9.教導及協助家屬每兩小時翻身，以維持皮膚的完整，避免壓力性損傷發生。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 唐景俠、黃秀雲、吳孟凌、宋寧娟、盤松青、李德芬、宋琇鈺、蔡玉梅、張淑娟、翁黃玲、胡名宏、張惠甄、盧星華、周心如、林琪馨、白玉珠、李芸玫、周學智、....、蘇淑芬(2021)．急重症護理學．台北市：華杏。
- (二) 張美玉、劉慧玲(2020)．實用重症護理學．台中：五南。
- (三) 葉美吟(2021)．頭部外傷之神經重症照護．臨床醫學月刊, 87(5), 290-293.
- (四) Konar, S., Maurya, I., Shukla, D. P., Maurya, V. P., Deivasigamani, B., Dikshit, P., ... & Agrawal, A. (2022). Intensive Care Unit Management of Traumatic Brain Injury Patients. Journal of Neurointensive Care, 5(1), 1-8.
- (五) Zrelak, P. A., Eigsti, J., Fetzick, A., Gebhardt, A., Moran, C., Moyer, M., & Yahya, G. (2020). Evidence-based review: nursing care of adults with severe traumatic brain injury. Am Assoc Neurosci Nurses, 42, 1-42.

主題名稱	頭部外傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/9

七、附件

(略)

主題名稱	頭部外傷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容與錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員通過會
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.04.07	3.1	更新第六項參考資料	104 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 更新第六項參考資料。 2. 修正護理問題與護理措施。 3. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目更新參考資料。 3. 第六項第六目新增參考資料。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.05.15	3.4	1. 第三項第七目之 9 壓瘡更改為壓力性損傷。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

